

Cette phase de développement duodénal, c'est une phase de rotation, c'est une phase d'organisation pour le cadre duodéno, intestin grêle et colique. Et là, on va le voir maintenant dans l'idée du cadre colique en rapport avec le duodénum. On me voit de profil, j'ai mon aorte, on va lire comme ça, de la profondeur sur le plan du cadre colique, que j'ai comme un mouvement de spirale, le duodénum, l'intestin grêle et le colon, dont le moteur pour l'organisation sera le foie. Si je regarde cette profondeur, on va voir que ça se développe dans ce qu'on appelle un pentagone facial organisé autour du pancréas. Vous vous souvenez, l'arrière-cavité des épiploons, j'ai le feuillet droit du péritoine viscéral au niveau de mon estomac, qui fait ce petit repli. Et tout de suite, par le... développement de mon foie, ça part vers l'arrière et ça fait une dynamique où l'estomac se positionne, où la partie droite devient postérieure et la partie gauche devient antérieure. Et ça crée cet espace. Au même moment, j'ai tout un développement de mon intestin qui commence à se faire. Pour le duodénum, qui sera surtout une rotation de 90 degrés de la gauche vers la droite, c'est un axe de rotation pour l'organisation hépatopancréatique, gastrique et linéale. Au départ, c'est droit. C'est un tube qui s'organise un peu en mouvement comme ça, avec l'intestin supérieur, l'intestin moyen et l'intestin inférieur. Mais dans cette phase de rotation, quand ça fait ceci, imaginez ce qui se passe ici. Il faut imaginer ça dans une croissance. Mais ça fait des espaces de mouvement, de torsion comme ça, de rotation intratissulaire. Et ces phases de rotation vont créer toute une zone qu'on appelle des sphincters. Donc l'ensemble de tous ces sphincters va être créé dans cette phase dynamique du développement. C'est comme des articulations. Une articulation, par exemple, le sphincter entre l'estomac et le duodénum, ça s'appelle le sphincter pylorique. Et on va voir que le sphincter pylorique répond à la mise en place entre le développement vers la droite de mon foie et le mouvement gastrique vers la gauche sur son axe de rotation, dont

le tissu qui se développe là-dedans va s'appeler le petit épiploon. Ça veut dire que le petit épiploon, sur le bord de mon estomac et au niveau hépatique, quand on prend un petit épiploon, c'est le tissu qui organise et qui rééquilibre le sphincter pylorique. Et on va commencer à réfléchir dans cette dynamique par rapport à cette puissance du développement. L'ensemble du mouvement, de l'organisation de tout ce développement va créer ce qu'on appelle les fonctions sphinctériennes. Au même moment, j'ai aussi mes deux ébauches pancréatiques, une ventrale, je vous rappelle que ça vient comme une glande, comme les poumons, c'est le même principe, comme le foie. Finalement, le foie, ce n'est qu'une expansion d'un tube digestif sur un plan endodermique. J'ai le pancréas, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, qui va faire cette phase de rotation, qui va suivre cette phase de rotation. Le pancréas va se développer dans ce mouvement aussi. Tout ce cadre du développement, de ce cadre profond au niveau du péritone, n'est qu'un mouvement qui s'est développé entre mon estomac, mon foie et le cadre colique, qui va organiser ces fonctions sphinctériennes. Le mouvement de mise en place détermine la fonction des sphinctères. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez le sphinctère pylorique qui est créé par le mouvement du foie et de l'estomac. C'est un point important pour toute la rotation définitive, rotatoire de 270 degrés du cadre colique. Tandis que le sphinctère 2D, lui, c'est la résultante définitive de la rotation du col édoque et du complexe pancréatique. C'est aussi un sphinctère très important. Si vous regardez dans cette mise en place, il y a ce mouvement pancréatique et ce mouvement du col édoque. Donc, ça veut dire que libérer un sphinctère 2D dans son fulcrum embryonnaire, c'est libérer le pentagone facial du pancréas et libérer le foie. C'est là où j'aurais mes deux points d'appui. Ce point-ci, c'est une grande zone réflexe enzymatique hormonale, biliaire et neurovégétative. Par exemple, sur le plan hormonal, il y a une relation

parathyroïdienne, avec des récepteurs au niveau calcique. Ici, ça correspond à la mise en place entre le foie et l'estomac. Le sphinctère 2D est un équilibre entre un fulcrum de développement de mon pancréas dans sa phase de rotation et de mon foie, sur le plan biliaire. Tandis que le sphinctère, cette fois-ci duodénal, est créé par la mise en place de l'intestin grêle, cette fois-ci, qui est une articulation entre le système duodénocolique en relation avec le système mésentérique. A ce niveau-là, les informations peuvent être modifiées par des informations gastro-iliales, par des informations colo-iliales, ou par des informations colo-gastriques. Ce petit point-ci est une des zones qui va modifier l'influx profond de toute la vascularisation digestive. Puisque, ici, j'ai un petit muscle magique qu'on appelle le muscle de Tretz, qui peut lever ou relâcher, et donc diminuer l'information qui vient de l'aval ou de l'amont, et diminuer, par rapport au tronc celiaque, l'information de type gastro-gastrique, ou bien linéale, ou bien hépatique. Donc ça veut dire que cette information, en fonction de l'information hypocalorique ou hypercalorique, par exemple d'un bol alimentaire, va modifier complètement ton comportement vasculaire. Donc tu vois comment ce point devient un point réflexe, devient un point super important, et qui n'est qu'une articulation entre l'intestin grêle dans sa phase de rotation qui se développe sur un plan où il vient d'abord se mettre dans l'intégrité antérieure puis vers la partie postérieure, où je vais avoir ici, en fait, toute la racine du mésentaire qui relie le duodénum au colon. Donc ce qui se passe là peut être un déséquilibre ici. Mais là-dessus j'ai, au niveau de mon colon, vis-à-vis de mon système diaphragmatique, j'ai le ligament suspenseur de l'angle entre le troisième et le quatrième duodénum qui peut ouvrir ou fermer l'information et donc diminuer l'espace vasculaire. On a encore un autre sphincter qui va se développer, c'est le sphincter iliosécal. Il est lié à la mise en place définitive de tous les cadres entre le mésentaire, et la descente du cadre définitif de l'angle

colique droit. Si je veux travailler un pylore chez un enfant, il y a une façon de positionner. Si je veux travailler un système immunitaire chez un enfant, il y aurait une façon de positionner. Il faut juste que le cerveau ait la connaissance du mouvement. Et le système va se faire tout seul. Tu lui donnes simplement son fulcrum. C'est-à-dire que la propre nature du système peut s'exprimer librement. Le sphincter anal, il sera lié sur l'axe de l'artère mésentérique inférieure. Toute l'information gauche est liée sur l'artère mésentérique inférieure. Toute l'information droite est liée sur l'artère mésentérique supérieure. Donc deux mouvements trophiques organisateurs de tout l'espace, mais centrés au niveau du diodénome. Parce qu'au niveau du diodénome, vous avez des fossettes diodénales qui peuvent, en fonction de l'ensemble, fermer ou augmenter ton système. Par exemple, une sigmoïdite en relation avec une fossette diodénale est liée sur un plan purement idiosécal. Chaque sphincter a au moins deux grandes fonctions. A la fois une fonction mécanique, pour changer le plan purement enzymatique, hormonal, neurovégétatif ou autre, et aussi une fonction de type information de type neurovasculaire. Ça va ouvrir ou fermer un environnement facial. Le plan musculaire du diodénome est un plan qui a un schéma splanchnique par la voie mésodermique commun au niveau diaphragmatique par le ligament suspenseur du dôme pleural, au niveau aortique, via le troncélic et toutes ses informations globales, via le système oesophagien et surrénalien. J'ai dans ce cadre une concentration d'informations un peu comme au niveau de ma symphyse phénobasilaire sur un plan d'analogie anatomique et physiologique. Je peux mettre la base du crâne dans un pentagone Christa Galli, les grandes ailes du sphénoïde, le système pétreux, l'occiput, etc. La même chose ici, je le retrouve dans un espèce de pentagone et le corps se construit dans un pentagone. Ce sera un autre travail sur les forces analogiques traité par exemple un bras. Il

faudra libérer une information sur un plan facial qui va se retrouver sur un niveau purement gastrique ou rénal ou surrénal ou une grande aile du sphénoïde. Je vous montrerai le lien presque synchronique entre par exemple la faux du cerveau et le ligament falciforme ou entre la racine primaire et secondaire au niveau sigmoïdien qui va se retrouver sur un niveau purement occipital pétreux ou sur un niveau dans le membre supérieur gauche parce que ce n'est qu'une expansion d'un système. Le diodénome, le foie, n'existe pas. C'est un environnement, c'est tout un tourbillon d'énergie avec des phases où il faut simplement s'appuyer. C'est juste un tube avec un environnement mais organisé spatialement et géométriquement. Cette géométrie nous permet de comprendre les analogies parce que vous avez vu à un moment donné dans le petit film, on voyait ça ici, les mouvements comme ça. En fait, on peut aussi étudier ce qui se passe comme ça. Ce qui va se développer là, vous allez voir que ça se développe en même temps. Nous, on prendra un pattern commun qui sera le développement du cerveau. Ça veut dire que de la part de l'articulation faciale de ce diodénome, il va déterminer finalement un état digestif de type métabolique. Si j'ai une alimentation, il va déterminer cet état digestif. Il va aussi déterminer un état végétatif. Ça veut dire qu'une déstabilisation de ton cadre diodénal parce qu'il bouge, peut donner par exemple une dystonie neuro-végétative, un état dépressif. Pour traiter une dépression, il faudra libérer un cadre diodénal. Il faudra remonter l'intestin. Il faudra redynamiser le système rien que sur un plan facial. Ça va redonner l'énergie sur le plan profond, sur le plan de la flore microbienne qui est un patrimoine génétique énorme qui informe par leur production et leur changement enzymatique sur un plan génétique, le plan cérébral dans sa fonction primaire. C'est une relation avec mes ganglions, avec mon système sympathique, parasympathique, avec mon système des ganglions semi-lunaire, droite-gauche, plexus mésentérique. À la fois

c'est facial, mais comme c'est bourré d'informateurs et de récepteurs, eux vont aussi fonctionner avec des plans de sérotonine. 80% de la sérotonine, quand même de l'hormone du bien-être, vient de l'intestin. Le plan du diodénaux est un des plans les plus informés sur le plan autocrine, paracrine et neurocrine. Dans le deuxième diodénum, en relation avec le sphincter de D, qui est rempli de glycocalyx. C'est simplement des récepteurs d'informations de type digestive ou autre. Quand ton alimentation arrive, c'est comme ça au niveau calorique, pancréas tu me libères ça, foie tu vas chercher ça, toi tu vas encore un peu plus brasser, on va aller chercher de la gastrine, il faut qu'on augmente notre acide chlorhydrique, c'est pur. Le diodénum, c'est un lieu concentré de ça. Sur un plan métabolique, cette compression peut entraîner la malabsorption de certaines protéines, comme des protéines en ose, le lactose et des lipides, de la vitamine D. La vitamine D est très importante pour l'absorption du calcium qui se fait au niveau du sphincter de D. Ça veut dire que l'ostéoporose peut avoir aussi un côté purement digestif par malabsorption sur les rapports de l'information hormonale entre la parathyroïde et des récepteurs duodénaux de l'information calcique. Ça veut dire que sur ce plan hormonal, c'est aussi finalement un rééquilibrage du système acidobasique qui va être répercuté cette fois-ci sur un plan neurovégétatif, sur le plan hypothalamique, qui va te redonner une chimie d'organisation qui va donc jouer sur l'organisation de tes sphincters. Sur un plan postural, c'est la chimie posturale acidobasique qui va être réorganisée par ton diodénome sur un plan hypothalamique et réorganisée dans ton système ergotrophes, paratrophes. Si je déplace mon bassin comme ça, j'ouvre un sphincter, je ferme un sphincter. Si je me mets comme ça, je ferme ici, j'ouvre là-bas. C'est toute une organisation dans ton corps qui va jouer pour augmenter ou diminuer le passage de l'information. Je vais retrouver dans ma posture une typologie de type constipatoire ou

bien de type diurétique. Donc je vais simplement modifier ma qualité de transfert d'information jusque sur un plan moléculaire. Donc ça veut dire que l'ostéoporose a une origine qui peut être digestif, reliée à un déséquilibre acidobasique au niveau gastro-duodénal puisque c'est le lieu de résorption sur le plan membranaire qui va se faire à ce niveau-là, sur le plan cellulaire, qui est déterminé par la gastrine, qui est déterminé par l'absorption au niveau du troisième duodénone et qui est aussi relié à la sécrétion de la thyrocalcitonine. Donc le sphincter de D sur un fulcrum entre le mouvement rotatoire de mon pancréas et le mouvement développemental de mon système biliaire. Ce sphincter de D sur un plan embryonnaire dans sa phase de développement est en relation avec le développement de mon foie et de mon pancréas. Le premier point fixe qui va se développer dans ce niveau-là sera l'angle colique gauche. Puis il y aura un autre point fixe qui va se faire sur le plan interne et le point le plus mobile qui sera l'angle colique droit, le sécum. Sur un plan chronologique, d'abord, un des premiers petits mouvements va être ce mouvement hépatique. Donc le moteur, le fulcrum principal va être le foie. Donc libérer la motilité du foie, redynamiser le foie, c'est redonner un point d'appui global pour le système. Regardez la concentration sur un plan vasculaire, artériel, sachant que j'ai aussi la relation avec l'estomac, avec le foie, avec mon pancréas, avec mon intestin grêle et donc directement avec mon colon, avec mon système de transverse. La ture anatomique ici est très importante et on va la voir en détail. Une déstabilisation du cadre duodénal peut être une déstabilisation de ta fertilité parce que vous avez ici une artère qui passe, qui est l'artère spermatique, l'artère ovarienne qui vient donner toute la trophicité. Vous avez l'artère mésentérique supérieure puis vous avez aussi l'artère mésentérique inférieure. Cette déstabilisation peut complètement dans sa profondeur déstabiliser le flux dynamique, hémodynamique. Et on va voir qu'un des maîtres de cette relation, ce

sera le muscle de Tretz. Pour le moment, ce que vous reprenez c'est qu'il y a une relation avec le petit épiploque qui va former mon premier sphincter. Le petit épiploque qui est le tissu d'articulation entre le foie et l'estomac qui va former le sphincter pylorique. Vous avez un deuxième sphincter très important qui est un sphincter 2D en relation avec le pancréas et le foie. Point d'appui des canaux biliaires ou canaux pancréatiques avec ce point enzymatique, ce point hormonal. Autre sphincter important ici, sphincter duodéno-géjunal en rapport avec le diaphragme via le muscle de Tretz en rapport avec le système colique via mon mésentère. Relation duodéno-géjunal et colique. Donc ce qui se passe ici peut s'exprimer là et donc influencer par exemple un déséquilibre sur le plan d'immunité puisque ça c'est un niveau immunitaire. C'est une concentration de tissus lymphoïdes qui fonctionne de façon synchrone sur un plan fluide donné par l'information des bactéries. L'important des cellules épithéliales c'est le glycocalyx dans le duodénum rempli de récepteurs. Avec son tissu d'environnement c'est son péritoine. Entre le mésocolon transverse ici, qui est là et le mésentère duodénum vous avez des petites fossettes qu'on appelle la fossette supraduodénale la fossette infraduodénale la fossette duodéno-géjunale qui sont quoi ? En fait des lieux de passage de niveau artériel. Ce péritoine ce sont des doubles lames porte-vaisseaux. Un stress trop important je vais avoir au niveau de l'arrière-capité des épiploques un viscérospasme et bien je vais diminuer la possibilité d'irrigation. Ces fossettes duodénales sont donc des fossettes artériovéneuses en relation naturellement avec mes reins en relation avec les veines mésentériques supérieures, mésentériques inférieures elle est profonde la mésentérique inférieure imaginez un problème pancréatique ou un viscérospasme j'ai mon pancréas je serre dans l'estomac que ce soit psychologique, que ce soit digestif ou que ce soit autre je diminue l'irrigation ça veut dire que ça va déterminer un état métabolique et digestif finalement sur le plan

sigmoïdien les coliques sigmoïdiennes les polypes sigmoïdiennes la rectocolique ulcéro-hémorragique tout ça c'est en relation avec non seulement les ganglions semilunaires donc le système sympathique, parasympathique et en relation avec l'épilée diaphragmatique traiter un problème de type sigmoïdite ou rectocolite hémorragique qui serait peut-être soi-disant d'une origine purement psychique trouve peut-être leur origine dans la profondeur de ton cadre diodénal et que libérer ce champ vasculaire c'est relibérer la trophicité même chose sur la droite si j'ai une déstabilisation j'ai une perte d'irrigation donc j'ai un problème de mauvaise irrigation sur le plan soit testiculaire, spermatique ou sur le plan ovarien ce qui se passe à la périphérie peut peut-être trouver une origine dans un simple viscérospasme entre le plan aortique et le plan diodénal ramener l'énergie relibérer le cadre profond pour retrouver ta sérotonine retrouver tes transmetteurs c'est relibérer ici aussi les surrénales les surrénales c'est vraiment des petits chapeaux super importants avec une partie périphérique et une partie centrale dont tous les neurotransmetteurs spécifiques viennent de la partie interne de tes surrénales et qui sont très importantes pour le système neurovégétatif pour le système de bon fonctionnement de tes neurotransmetteurs du cortisol qui peut inhiber ta thyroïde ou tes facteurs hypophysaires simplement par une mauvaise adaptation au stress ça nous montre que le diodénome il est informé par la mobilité des reins qui est informé par la mobilité de ton foie la capsule de glissons peut déstabiliser tout ton axe de drainage lymphatique on sait que le fascia périrénal donc au niveau de ce lit du psoas draine jusqu'à un litre à un litre et demi de lymphe par jour donc ça veut dire que c'est tout ton système de poubelle qui doit s'équilibrer regardez ce muscle de traite c'est vraiment une continuité du diaphragme c'est un des carrefours les plus importants sur le plan vasculaire de ton système digestif c'est mon troncélic, j'ai tout le système hépatique gastrique, diodénal linéal qui part de là je monte je fais un

viscérospasme je change l'état vasculaire ici il est fait de deux parties d'une partie musculaire et d'une partie fibreuse donc deux types d'informations différentes je vais avoir une relation directe avec le nerf phrénique ce qui est en relation avec le centre phrénique donc avec ma colonne cervicale donc avec C3, C4 directement ici par musculaire, par réflexe comment ceci peut donner des douleurs d'épaule ou des douleurs cervicales en libérant cette zone là vous allez libérer votre rotation cervicale immédiatement c'est normal puisque c'est une voie réflexe n'oubliez pas que ça fonctionne comme ça que ces viscérospasmes peuvent se répercuter via des fibres sensibles dans le système et en fait au lieu de repartir là dedans ils repartent sur des voies motrices latérales j'ai ma C3 j'ai ma C4 non seulement j'ai le nerf phrénique mais j'ai une relation vis-à-vis des ganglions où je vais repartir dans d'autres systèmes entre autres l'irrigation ou l'innervation au niveau cervical ou au niveau simplement de ton bras ou de ton coude ça c'est une voie neurologique mais tu as aussi une voie faciale puisque c'est une expansion de ton sac cardio-pleuro-péritoniel si je tire ou si je ferme augmenter ou diminuer l'angle duodéno-géjunal donc je peux avoir un état réflexe sur le plexus solaire par voie mésentérique avec une voie lymphatique lymphatique, lymphatique, mésentérique et puis je me retrouve sur des plexus ergotrophes ou trophotrophes par la concentration de ganglions de type parasympathique ou orthosympathique avec mon aorte qui va se retrouver dans des phases de rotation je peux déstabiliser mon cœur par un mouvement aortique ici donc je peux libérer une aorte ici pour libérer une branche ici et donc libérer toute une information ici c'est à dire que c'est un point d'appui c'est là où on va le relâcher ici c'est là où on va le rééquilibrer qu'est-ce qui l'entoure là ? l'œsophage qu'est-ce qui l'entoure là ? le troncéliaque et là qu'est-ce que j'ai ? mésentérique supérieure donc toute l'arcade ici et un peu plus bas qu'est-ce que j'ai ? toute la mésentérique inférieure vous

comprenez un peu l'idée de cette puissance de ce pentagone facial ?
je prends tous mes fascias et je fais comme ça et maintenant je tire j'ai tout et là je suis attaché et Steele disait toute votre colonne, tout votre périclone tous vos intestins sont attachés à l'aorte et à la colonne vertébrale le muscle de Tretz informe sur le débit sanguin au niveau intra-péricloneal et au niveau sus-mésocolique le muscle de Tretz est informé par tous les cadres par un plan métabolique et par un plan mécanique et surtout ne pas oublier sa relation avec le rein le psoas qui peuvent par exemple nous donner une gonalgie il faudra reconcentrer le périclone dans son fulcrum d'origine et aussi dans son point terminal non seulement il a son fulcrum mais il a aussi son point d'arrivée c'est de sa concentration électrique pure sur un plan magnétique sur un plan énergétique il y a une énergie subtile qui circule parce qu'on peut remettre ça dans un pentagone comme ceci iliosécale hépatique gastrique colique gauche point d'appui très important sigmoïdien puis je rentre dans la petite étoile ici, ici, ici, ici voilà les points clés d'un travail du périclone et ce petit épilomb c'est lui qu'on va apprendre à aller le dégager j'ai à la fois une lame hépatique l'artère hépatique et les voies biliaires donc j'ai un niveau très important purement métabolique de type digestif et circulatoire bon mon petit épilomb il est là il est comme ça on va partir du côté droit ici là j'ai la lame hépatique pure vasculaire je me retrouve avec la vaneporte la vaneporte j'ai ici mon conduit hépatique et j'ai ici l'artère hépatique propre enfin tout ça c'est maintenu, tenu dans le petit épilomb donc non seulement j'ai un point d'appui embryonnaire très important mais non seulement j'ai un point de liberté de tout mon retour métabolique de type veineux ici j'ai tout ce côté-ci sigmoïdien qui vient ici et là j'ai tout ce côté sécal qui revient ici et ici j'ai toute la relation avec mon deuxième diodénum sur ce conduit biliaire et tout ça c'est enfermé dans un fascia ensemble je suis maintenu avec une part après qui est un bord plutôt libre et un bord

plus condensé après qui reprend le méso complet du feuillet droite, du feuillet gauche de mon plan gastrique là je prends l'estomac et entre mes deux vanes porte artère hépatique conduit biliaire ici là j'ai un bord plus souple et puis derrière ici j'ai un bord plus libre et là je vais simplement aller dans un état global petit à petit redonner cette liberté du tissu depuis la surface et là j'ai vraiment l'axe de rotation entre mon foie et mon estomac donc j'ai toute l'organisation future de mon arrière cavité des épiploons et de toute la rotation diodénale primitif donc cette première portion du diodénum on peut dire qu'elle est en relation avec la partie postérieure du feuillet est en continuité avec la foie hépatique donc c'est le conduit de la vane porte qui détermine donc le débit du retour et donc tous les rééquilibrages des stases sigmoïdiennes ou coliques c'est fixé aussi par le fascia traité, cadre diodénal stabilité hépatique stabilité diaphragmatique le deuxième diodénum est en relation avec le système hépatocystico-colique c'est à dire avec aussi mon urètre et le diodénum donc c'est important de traiter les reins de libérer le fascia périrénal de libérer le psoas quand on traite un diodénum le troisième diodénum sera en relation surtout avec le système lombaire moyen L3 L4 avec toute la relation au niveau de l'artère ovarienne et l'artère testiculaire donc tous les problèmes de fertilité j'ai toutes mes relations vis-à-vis de mon deuxième diodénum avec mon diaphragme et qui a un lemme diaphragmatique j'ai un lemme ici par ce jeu ici là et puis j'ai un grand lemme sur mon plan du bassin qui est en relation avec un grand lemme l'hiatus de Winsow c'est la porte d'entrée de l'arrière cavité des épiploons tu vois ce mouvement qui fait ça quand je pars, je rentre c'est l'hiatus de Winsow puis je rentre dans le vestibule pour ma promenade le chemin de la connaissance ostéopathe toujours important d'étudier de l'embryologie qui va te faire comprendre l'anatomie l'anatomie va te faire comprendre la physiologie la physiologie va t'amener à une étude de la

physiopathologie puis tu vas comprendre dans la physiopathologie qu'il y a un lien avec la psychologie la psychologie va t'amener sur la philosophie et la philosophie va t'amener sur la spiritualité ça veut dire que tu vas pouvoir libérer ton plan d'attachement profond pour oser retrouver ta vacuité et ça à chaque acte respiratoire tu rends à chaque fois ton souffle si tu rends vraiment, tu peux mourir en paix finalement tout le travail c'est de mourir en paix c'est pour ça que la méditation c'est un entraînement de la mort à chaque instant